

Zimmerhygiene

Händehygiene, Schutzausrüstung, Flächen und Isolation. Kompakt nach KRINKO und RKI

5 Momente

Händedesinfektion

Ausziehtechnik

Flächen

Isolation

5

Indikationen
Händehygiene (WHO)

Desinfektion

Routine ist kein Waschen

1

Handschuhpaar pro
Tätigkeit

Produkt

Einwirkzeit laut
Herstellerangabe

Die 5 Indikationen der Händehygiene

1. Vor Patientenkontakt	Vor dem Berühren des Patienten oder seiner Umgebung.
2. Vor aseptischer Tätigkeit	Vor Katheter, Verband, Injektion, Zugang, Absaugung.
3. Nach Kontakt mit Körperflüssigkeit	Nach Gefahr durch Blut, Sekret, Ausscheidung, auch bei Handschuhen.
4. Nach Patientenkontakt	Nach dem Berühren des Patienten und nach dem Ablegen der Handschuhe.
5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung	Nach dem Berühren von Bett, Nachttisch, Monitor, Infusionspumpe.

Händewaschen oder Händedesinfektion?

Im Pflegealltag gilt die **hygienische Händedesinfektion** mit alkoholischem Präparat als Standard. Sichtbar verschmutzte Hände oder Kontakt mit Sporen (z. B. *C. difficile*) erfordern Waschen mit Seife und anschließende Desinfektion nach Hausstandard.

Regel: Hände trocken, Präparat vollständig verreiben, Einwirkzeit laut Herstellerangabe einhalten. Hände nicht vorher abtrocknen, nicht nachwischen.

Handschuhe

Wann	Bei möglichem Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeit, Schleimhaut oder kontaminierten Flächen. Keine Routine-Handschuhe für jede Tätigkeit.
Wechsel	Zwischen zwei Patienten und nach jeder Tätigkeit mit Kontamination. Immer Händedesinfektion nach dem Ausziehen.
Ausziehen	Handschuh 1 an der Außenseite am Rand fassen, abziehen. Handschuh 2 nur mit den Fingern der noch behandschuhten Hand am Innenrand fassen, nach außen abziehen. Keine Außenseite berühren.

Schutzkleidung

Schutzkittel	Bei Gefahr der Durchnässung oder Kontamination der Kleidung. Vor dem Betreten des Zimmers anlegen, vor dem Verlassen ablegen.
Mund-Nasen-Schutz	Bei Tröpfchen- oder Aerosol-Infektionen laut Hausstandard, bei Flüssigkeits-Spritzgefahr auch Augenschutz.
Ablegen	Handschuhe zuerst, dann Kittel, dann Händedesinfektion. Gesicht und Kleidung nicht berühren.

Flächen- und Gerätedesinfektion

Häufig berührte Flächen	Bettgitter, Nachttisch, Klingel, Lichtschalter, Türgriffe, Pumpen, Monitore. Routine-Wischdesinfektion nach Hausplan und bei sichtbarer Verschmutzung.
Präparat	Nur für den Zweck zugelassene Flächendesinfektionsmittel nach Liste (VAH/DGHM) verwenden. Konzentration und Einwirkzeit laut Hersteller.
Geräte	Gerät vor Weitergabe reinigen und desinfizieren. Herstellerangaben zu Materialverträglichkeit beachten.
Reinigung vor Desinfektion	Sichtbare Verschmutzung zuerst entfernen. Desinfektion wirkt nicht auf Schmutz.

Wäsche und Abfall

Schmutzwäsche	Im Zimmer direkt in den Wäschesack, nicht sortieren oder ausschütteln. Sack geschlossen transportieren.
Abfall	Hausübliche Trennung, Infektionsabfall in den gekennzeichneten Behälter. Behälter nicht überfüllen.
Spitze und Scharf	Nadeln und Skalpelle nicht ummanteln oder zurückstecken. Sofort in den durchstichsicheren Behälter.

Isolationsmaßnahmen (Kurzübersicht)

Kontaktisolation	Schutzkittel und Handschuhe beim Betreten. Eigenes Material im Zimmer, Patientenzimmer bei Bedarf kennzeichnen.
Tröpfchenisolation	Mund-Nasen-Schutz beim Betreten, Abstand zum Patienten. Patient bei Transport Mund-Nasen-Schutz.
Aerosolisolation	Partikelfiltrierende Maske (FFP) und Einzelzimmer mit Unterdruck laut Hausplan.

Achtung: Die konkrete Isolationsmaßnahme richtet sich nach dem Erreger und der ärztlichen Anordnung, nicht nach dieser Übersicht.

Quellen zur Prüfung: KRINKO/RKI-Empfehlungen (Händehygiene, Flächendesinfektion, Isolierung), WHO „Five Moments for Hand Hygiene“, VAH-Liste.